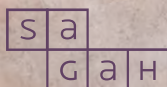


GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Gésica Graziela Julião



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Áreas produtivas em saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você será capaz de:

- Identificar as áreas produtivas em serviços de saúde.
- Relacionar cada área produtiva com o processo organizacional.
- Descrever a participação de cada área nos resultados da organização.

Introdução

Os serviços de saúde têm características peculiares, seja pela formação dos recursos humanos, pela forma de organização, pela natureza do serviço, pela grande demanda por atendimento de qualidade e/ou pela constante oferta por serviços alternativos. Esses elementos resultam em maior dificuldade de gestão desses serviços e exigem um aumento de produtividade.

Sabe-se que produtividade diminuída pode contribuir para o aumento dos custos dos serviços prestados, do desemprego e da baixa qualidade de vida. Por isso, é importante um modelo de gestão que incentive uma cultura organizacional voltada para a busca constante por inovação, melhoria de produtividade e aumento da eficiência dos serviços.

Neste capítulo, você vai conhecer as áreas produtivas em serviços de saúde, relacionando-as com o processo organizacional e entendendo a sua participação nos resultados da organização.

1 Conceitos básicos

O sistema de saúde brasileiro é composto por serviços público e privado, gerenciados pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Atualmente, a área da saúde é uma das principais atividades econômicas do país, com importante representatividade no Produto Interno Bruto (PIB) e na geração de empregos. Uma instituição de saúde é um sistema produtivo de assistência à saúde no qual as áreas de abastecimento atendem as necessidades de insumos

e de equipamentos dos profissionais de saúde para a realização do atendimento (INFANTE; SANTOS, 2007).

Os setores de uma instituição hospitalar, por exemplo, têm aumentado em número e complexidade, tanto pela necessidade da demanda quanto pelo desenvolvimento tecnológico que permite essa especificação. O ambiente hospitalar comporta desde tecnologias leves até tecnologias duras. **Tecnologias leves** são aquelas realizadas predominantemente pelos recursos humanos, enquanto as **tecnologias duras** necessariamente necessitam de equipamentos complexos e sofisticados de diagnóstico e tratamento em busca da recuperação da saúde. A tecnologia atinge não apenas os setores diagnósticos e terapêuticos, mas também os setores de apoio técnico e, por isso, contribui diretamente com a produtividade de toda a instituição.

São consideradas áreas produtivas em saúde aquelas que geram o cuidado. Na área da saúde pública, são todos os serviços que prestam assistência direta à saúde do paciente, ou seja, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), responsáveis pelo atendimento primário em saúde; os Centros de Atenção Psicossocial (CAP), responsáveis pela assistência psiquiátrica infantil, adulta e de usuários de substâncias psicoativas como álcool e outras drogas; os Serviços de Atendimento Especializado, que podem ser destinados às doenças infectocontagiosas; as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) responsáveis pelos serviços de urgência e emergência; e os hospitais públicos, entre outros serviços que variam de acordo com cada município ou região. No setor privado, são basicamente as clínicas e hospitais privados.

Como vemos, os hospitais possuem características estruturais específicas e áreas administrativas, áreas produtivas e áreas de apoio. As áreas administrativas são compostas por direção, gerências e coordenações das diversas áreas. As áreas produtivas são as unidades de assistência direta ao paciente. As áreas de apoio são aquelas que dão suporte às áreas de assistência, como o serviço de nutrição e dietética, a lavanderia, a farmácia e o centro de materiais esterilizados (CME) (CROZATTI, 1998).

Entre as áreas produtivas da instituição hospitalar, temos o pronto-atendimento e o ambulatório, responsáveis pelo primeiro atendimento do paciente na maioria das situações. Esses setores realizam assistência às urgências e emergências, consultas médicas e de enfermagem, exames laboratoriais e de imagem, além de assistência traumatológica e pequenos procedimentos, como curativos, troca de sonda vesical, gástrica e enteral, sutura, retirada de pontos, administração de medicamentos, cantoplastias, entre outros.

As unidades de internação são várias e presentes de acordo com cada instituição. Elas prestam atenção à saúde do paciente nas mais variáveis situações e podem ser maternidade, pediatria, unidades clínicas, cirúrgica e psiquiátrica. As unidades de terapia intensiva podem ser de adulto, pediátrica e neonatal,

ou seja, são adaptadas de acordo com a faixa etária e a especificidade da assistência médica. Além disso, existem os centros cirúrgicos, que realizam procedimentos médicos mais complexos, e centros obstétricos, que prestam assistência específica à gestante e à parturiente.

Portanto, cada instituição possui sua estrutura específica de acordo com as demandas da região onde está inserida. A produtividade de cada área também pode variar, considerando o porte do hospital e se ele é referência em determinada área ou não. Diante da complexidade desse cenário e das variáveis apresentadas, é necessário que as instituições possuam uma estrutura organizada, com processos bem definidos, para que sejam capazes de mensurar e ampliar sua produtividade.

2 Áreas produtivas e processo organizacional

A reestruturação produtiva é um processo de transformações estruturais tanto na produção quanto no trabalho que tem o objetivo de criar um novo modelo tecnológico e organizacional com a implantação de novas formas de gestão e organização do trabalho (PRATA; PROGIANTI; DAVID, 2014). A flexibilidade é uma característica importante desse processo produtivo, uma vez que tolera mudanças de acordo com a demanda e com o mercado, considerando, ainda, a eficiência e a redução dos custos (BECKER; RUAS, 1997).

A organização dos serviços de saúde é compartimentada em setores ou departamentos com funções bem definidas e preestabelecidas, que são inter-relacionadas, porém independentes, e possuem como objetivo oferecer um atendimento de qualidade ao usuário que procura esses serviços. Essa divisão por setores, se feita de forma rígida, pode culminar em uma fragmentação excessiva de tarefas e elevada especialização dos diferentes profissionais atuantes na área. Para o gestor, esse pode ser um fator de dificuldade para manter um bom padrão de desempenho institucional.

Para atingir plenamente seus objetivos, é preciso que a instituição mantenha uma estrutura organizada de forma racional, considerando as relações que devem ser realizadas entre as pessoas e os setores de acordo com a assistência ofertada, de tal forma que favoreça a produtividade da instituição. Isso é importante, pois as atividades de atenção à saúde são complexas e sequenciais, ou seja, para cada procedimento, são necessários insumos e processos específicos de trabalho, que podem variar de acordo com o paciente, a instituição ou o profissional (CROZATTI, 1998).

As tendências em tecnologias e organização na área da saúde têm incentivado os gestores de instituições hospitalares a buscar constantemente novas alternativas para melhorar a qualidade da assistência, a competitividade de

seus serviços e a satisfação do cliente, ao mesmo tempo que precisa reduzir os recursos financeiros, materiais e de recursos humanos para a realização de cada tarefa em alinhamento às estratégias organizacionais.

Sabemos que a forma de organização hospitalar conta com processos técnicos e administrativos complexos que exigem uma rotina alinhada às necessidades dos profissionais de saúde e dos pacientes para manter a organização em funcionamento. A padronização de processos interfere diretamente na produtividade, na qualidade e na eficácia da assistência, e, por isso, é essencial para gerenciar os serviços hospitalares (BITTAR, 1996).

Existe uma diversidade populacional muito grande em todas as regiões do nosso país, e as pessoas estão mais atentas à qualidade do serviço que elas consomem independentemente do setor. Na área da saúde não seria diferente, pois, além do atendimento humanizado, considera-se o conforto da hotelaria, os equipamentos tecnológicos utilizados e o conhecimento do profissional. Por isso, a oferta de um serviço de qualidade depende de uma estrutura organizacional adequada, de processos definidos, de uma equipe capacitada e de uma gestão efetiva.

O envolvimento da equipe na implantação, no desenvolvimento e na manutenção dos processos organizacionais das diferentes áreas produtivas da instituição é um fator importante para atingir os objetivos da instituição. Quando as pessoas estão envolvidas no processo, elas buscam aperfeiçoamento, o que facilita o alcance da excelência por meio das melhorias constantes. Disseminar os processos implantados para os fornecedores e clientes também é uma conduta gerencial que minimiza retrabalhos e proporciona maior segurança.

Para a gestão dos serviços, os processos organizacionais passam de setoriais para funcionais, inter-relacionando as diversas áreas da instituição. Os processos favorecem a construção da cultura organizacional de constante melhorias internas e externas e, quando bem definidos, podem aumentar a produtividade e reduzir o tempo de identificação de um problema, facilitando a tomada de decisão pela gestão (CROZATTI, 1998).

Além dos benefícios citados, a implantação de processos trazem benefícios como:

- facilitar a continuação das atividades desenvolvidas;
- ser um instrumento de consulta de fácil acesso;
- ser base para treinamento dos recursos humanos;
- aumentar a capacidade técnica dos profissionais;
- permitir a identificação da importância de cada etapa do processo no resultado final, estimulando, assim, o trabalho em equipe.

Em contrapartida, se o processo não for bem estruturado e executado, pode levar a mais transtornos do que resultados positivos para a instituição, assim como, se não for periodicamente revisado, perde sua utilidade e não atende as variações do mercado.

A visualização de um processo, a especificação de cada atividade que compõe o fluxograma da atividade e a documentação de forma objetiva e clara, a fim de facilitar o entendimento e minimizar a necessidade de explicações, são fundamentais para seu gerenciamento (INFANTE; SANTOS, 2007). O fluxograma serve como uma ferramenta de verificação das rotinas desenvolvidas, de padronização na execução das tarefas e para as análises de melhorias dos processos.



Fique atento

Para padronizar uma tarefa ou atividade, em primeiro lugar, precisa-se discutir com todas as pessoas envolvidas a melhor maneira de realizá-la, treinar e capacitar as pessoas e certificar-se de que as atividades estão sendo realizadas conforme previamente combinado. Padronizar os processos permite a melhoria na produtividade e nos resultados. Após treinar as equipes, é preciso praticar as atividades para testar, avaliar e corrigir possíveis falhas, a fim de controlar e garantir a qualidade desejada pelos clientes e o retorno econômico para a instituição. Portanto, o processo de padronização das atividades deve ser flexível e de fácil entendimento, de modo que todos os sujeitos envolvidos contribuam para sua implantação e execução.

Ao frequentar um serviço de saúde, muitas vezes, o paciente não foca no procedimento em si, mas, sim, no resultado, na melhora de sua situação de saúde. Quem decide quais procedimentos serão realizados para atingir esse resultado é o profissional de saúde. Por isso, um profissional comprometido, com uma visão crítica e responsável será capaz de fazer melhores escolhas dentro dos processos estabelecidos pela instituição, com o objetivo de melhorar a saúde do paciente com menor custo, maior eficácia, alta produtividade e qualidade de assistência.

3 A participação de cada área nos resultados da organização

Assim como cada empresa tem características próprias, as áreas de uma organização também se caracterizam por desempenhos individuais e diferenciados umas das outras. Essas diferenças podem ser na eficiência, na eficácia, na estrutura física

ou na utilização de recursos materiais. Para medir essa produtividade, podemos utilizar vários tipos de indicadores (BITTAR, 1996), como a média de permanência — o tempo que o paciente fica internado, considerando que as tecnologias atuais diminuíram consideravelmente o tempo necessário para a recuperação do paciente — e o índice do intervalo de substituição, que diz respeito ao tempo durante o qual o leito fica desocupado, importante indicador de produtividade.

Todas as atividades realizadas dentro de um serviço de saúde consomem recursos e geram serviços. No entanto, o modo como cada atividade é executada em cada área ou de forma global depende das regras, dos valores e processos organizacionais instituídos, uma vez que a cultura organizacional impacta diretamente nos níveis de eficiência e eficácia das atividades executadas (CROZATTI, 1998). Para analisar a relação de produtividade, o gestor busca o setor que melhor utiliza os recursos humanos, materiais ou financeiros sem perder a qualidade na assistência. A gerência objetiva os indicadores de menor tempo de permanência, menor índice de intervalo de substituição e o mínimo de funcionários por leito.

Algumas áreas, contudo, têm sua produtividade diretamente relacionada com a quantidade de recursos humanos, como é o caso da enfermagem. Por isso, o gestor deve avaliar a produtividade tanto de forma global quanto setorial para que as considerações finais correspondam à realidade. Os indicadores setoriais dizem respeito a quanto as diferentes áreas produzem resultados de forma individual, enquanto o global corresponde ao resultado de toda a organização.

O momento atual exige dos serviços de saúde crescentes níveis de eficácia, que, invariavelmente, impactam em mudanças organizacionais. A mudança cultural é o caminho para o aumento da produtividade e eficácia das instituições. As crenças e valores da organização precisam estar alinhados aos processos, de modo a alcançar uma harmonia com aquilo que a população espera desses serviços e com o que os funcionários esperam da organização. Para tanto, o gestor deve priorizar a interação entre as diversas áreas que compõem a instituição, pois, quando os resultados de uma área forem compatíveis ou próximos das demais, haverá um aumento de eficiência e, consequentemente, diminuição de fatores que comprometem a produtividade.

Manter um programa de avaliação da produtividade permite aos gestores implantar metas gerenciais para a melhoria dos processos de acordo com a capacidade de trabalho e recursos disponíveis. Para gerenciar com produtividade, os indicadores de cada processo dentro de uma área são utilizados para medir o seu desempenho e a satisfação do cliente. O conjunto de indicadores hospitalares também serve para monitoramento do Ministério da Saúde, que, a partir dos resultados obtidos pela instituição, define os recursos financeiros que serão encaminhados, bem como analisa a possibilidade de crescimento, implantação de novos serviços ou descredenciamento.

Um indicador fundamental para o Ministério da Saúde, por exemplo, é o número de cesarianas e partos vaginais realizados por período, uma vez que existem programas do governo que incentivam a realização do parto mais natural possível, sem intervenções cirúrgicas. Por esse e por outros indicadores, o Ministério da Saúde recebe todos os meses um relatório eletrônico das instituições hospitalares, com os dados de internações, atendimentos de urgência e emergência, causas dos óbitos, índice de infecção hospitalar, entre outros. Essas informações são disponibilizadas em uma plataforma eletrônica do Ministério da Saúde chamada Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Esse banco de dados é muito utilizado para estudos e pesquisas do governo e de pessoas físicas (PRATA; PRO-GIANTE; DAVID, 2014).

Portanto, os resultados da instituição dependem de cada área que a compõe, pois envolvem a satisfação dos colaboradores, dos fornecedores e dos clientes, a produtividade de cada setor, o trabalho em equipe e a tomada de decisão. Nesse sentido, a gestão deve incentivar e trabalhar para que o ambiente interno esteja coeso e para que cada pessoa tenha consciência da responsabilidade que suas atividades representam sobre os resultados da instituição. Assim, as decisões tomadas pela gestão levarão à definição de melhores planos de ação, a fim de garantir a continuidade e o aumento dos níveis de eficácia, ao mesmo tempo que criam um ambiente favorável para discussões e propostas de novas ideias pelos sujeitos envolvidos.



Referências

BECKER, G. V.; RUAS, R. L. Estratégias de comprometimento e planos de participação nos lucros: tendências recentes. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 1, n. 3, p. 141-161, 1997. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141565551997000300008&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 9 jan. 2020.

BITTAR, O. J. N. V. Produtividade em hospitais de acordo com alguns indicadores hospitalares. *Revista de Saúde Pública*, v. 30, n. 1, p. 53-60, 1996. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101996000100007&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 9 jan. 2020.

CROZATTI, J. Modelo de gestão e cultura organizacional: conceitos e interações. *Caderno de Estudos*, n. 18, p. 1-20, 1998. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-92511998000200004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 9 jan. 2020.

INFANTE, M.; SANTOS, M. A. B. A organização do abastecimento do hospital público a partir da cadeia produtiva: uma abordagem logística para a área de saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 12, n. 4, p. 945-954, 2007. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2007.v12n4/945-954/>. Acesso em: 9 jan. 2020.

PRATA, J. A.; PROGIANTI, J. M.; DAVID, H. S. L. Uma reestruturação produtiva na área da saúde e da enfermagem obstétrica. *Texto Contexto Enfermagem*, v. 23, n. 4, p. 1.123-1.129, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n4/pt_0104-0707-tce-23-04-01123.pdf. Acesso em: 9 jan. 2020.

Leituras recomendadas

BORBA, V. R.; LISBOA, T. C. *Teoria Geral de Administração Hospitalar: estruturação e evolução do processo de gestão hospitalar*. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.

GONÇALVES, E. L. (org.). *Gestão Hospitalar: administrando o hospital moderno*. São Paulo: Saraiva, 2006.

MALAGÓN-LONDOÑO, G.; LAVERDE, G. P.; LONDOÑO, J. R. *Gestão Hospitalar: para uma administração eficaz*. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

**Fique atento**

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS